

01 - 02- Trouble Anxiété Généralisée - Pr. Laffinti

C'est une maladie qui est caractérisée par la présence d'une tension anxieuse, mais qui est plus permanente, donc plus prolongée, et par un sentiment d'appréhension associé à des soucis qui sont excessifs et durables, donc qui se prolongent dans le temps au-delà de six mois. C'est une pathologie aussi assez fréquente, qui peut être gênante, voire handicapante à un certain degré, et qui constitue un motif assez rencontré dans les consultations, souvent pour d'autres symptômes autres que psychiques, mais on trouve souvent chez les patients un terrain d'anxiété généralisée qui est très fréquent. Cette consultation dans les différentes structures de soins est à l'origine d'une surconsommation du soin avant que le diagnostic soit établi et une prise en charge correcte ne soit faite.

C'est une pathologie dont l'évolution peut être de plusieurs années, chronique, et qui expose à énormément de comorbidités, on va le voir. Sur le plan épidémiologique, c'est comme la majorité des troubles anxieux, donc ça touche deux fois les femmes que les hommes, avec une prévalence de l'ordre de 6% chez les femmes, 3% chez les hommes en population générale. Comme vous le voyez, pour l'enquête nationale, c'est plus de 9%, c'est-à-dire la fréquence du trouble.

La survenue du trouble survient un peu plus tardivement par rapport au trouble de panique, donc avec un pic à 35 ans chez les femmes et un peu plus tard chez les hommes. Mais on peut bien sûr voir le trouble à n'importe quel âge et surtout chez les âges plus avancés et c'est considéré comme le trouble anxieux le plus fréquent chez le sujet âgé. Certains facteurs de risque, comme pour la majorité des pathologies psychiatriques, c'est certaines situations de célibat, de veuvage, de séparation, des problèmes socio-économiques qui peuvent être le lien et un facteur de risque surajouté.

Sur le plan clinique, on va étudier la clinique du trouble. Comme on l'a dit dans la définition, c'est un trouble caractérisé par la présence d'une anxiété ou une tension anxieuse permanente et par des soucis. Concernant les soucis, ce sont des soucis que toute une personne normale, qu'on pourra tous avoir dans notre vie quotidienne, mais qui prennent de l'ampleur d'une dimension assez pathologique chez les personnes ayant un trouble d'anxiété généralisée.

Ce sont des soucis qui ont un rapport avec les différents faits, les différents événements de la vie quotidienne, mais pour ces gens-là, ces soucis deviennent plus permanents, ils occupent une part importante du temps, ils sont durables, donc ce n'est pas quelque chose de passager lié à une circonstance particulière, mais quelque chose de plus durable et que la personne ne peut pas s'empêcher d'y penser et a du mal à s'en débarrasser. Donc ça envahisse l'esprit de ces gens, ça crée une situation et un sentiment de malaise important et ces soucis peuvent être en rapport avec n'importe quel thème de la vie quotidienne, on va le voir. Donc on dit que ce sont des soucis pour tout et pour rien, donc tout fait banal de la vie quotidienne, tout événement peut constituer un véritable problème ou créer de véritables inquiétudes chez ces personnes-là, ça

pourrait être le travail, donc les gens qui font des soucis par rapport à leur travail, par rapport à leur avenir, par rapport au licenciement, à la perte de travail, à se retrouver au chômage, donc par exemple un secrétaire dont le patron lui demande par exemple de lui préparer une liste de clients, par exemple la semaine dernière, donc il va prendre ça comme un véritable problème, va commencer à parler à elle-même et dire peut-être que je n'y arriverai pas, donc je n'ai pas encore mis à jour la liste des clients, le patron risque d'être fâché, je risque de perdre carrément mon poste, donc elle commence dans une cascade d'anticipation d'éléments péjoratifs et négatifs et c'est vraiment une sorte de monologue interne qui s'installe dans le sens négatif.

Ça pourrait aussi être des soucis en lien avec la santé, soit pour la personne elle-même ou il s'inquiète pour les gens de sa famille, donc si une personne par exemple qui est en consultation chez un médecin lui demande un bilan un peu inhabituel juste à titre d'exploration, sans qu'il y ait vraiment quelque chose d'inquiétant et va se dire pourquoi ce médecin m'a demandé cela, il ne m'a rien dit, peut-être qu'il a pensé à quelque chose de grave, peut-être que j'ai une maladie assez grave, donc peut-être qu'il va aller consulter d'autres médecins et rentrer dans ce genre de questionnement. Ça pourrait aussi être des soucis par rapport à la famille. Je disais que ce sont des soucis qui peuvent être en rapport avec n'importe quel fait banal de la vie quotidienne, donc je disais que ça pourrait aussi être concerné à la famille, donc une femme qui va voir par exemple son mari sortir le matin un peu pressé, sans pouvoir prendre sa tasse de café habituelle, elle va commencer à se dire qu'elle n'a pas pu prendre sa tasse de café, peut-être qu'il sera moins vigilant avec le risque du transport, l'embauchage, donc il risque d'avoir un accident, il va aller même à l'harcèlement par des appels téléphoniques, est-ce que tout va bien, dites-moi que tu es bien arrivé, est-ce que tout va bien, rien de grave, mais même si par exemple l'époux essaie de la rassurer, il va continuer à se créer des scénarios catastrophiques dans ce sens.

Donc ce sont ce genre de soucis que ces personnes se font et ça peut être n'importe quoi, des fois des trucs plus simples, donc une mère qui a déposé par exemple son enfant à l'école, à la crèche, il était peut-être un petit peu fébrile le matin, il va commencer à s'imaginer des scénarios catastrophiques, elle était fébrile, j'ai oublié de lui donner son paracétamol, peur qu'il va s'aggraver, je dois alerter par exemple la direction de l'école, même si elle alerte la direction de l'école, ça ne va pas la rassurer, il va se dire peut-être que la responsable n'a pas eu le temps d'avertir la maîtresse, donc il peut aller jusqu'à se déplacer carrément à l'école pour voir est-ce que tout va bien. Ça pourrait aussi être des choses plus banales, par exemple une femme au foyer qui en allumant le gaz n'arrive pas à allumer, donc la bonne boîte de gaz est déchargée, ça pourrait être un véritable souci juste parce que le déjeuner risque d'être en retard d'une demi-heure ou d'une heure, mais pour elle ça pourrait être un véritable souci qui crée beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'angoisse. Ou même le fait de manquer un rendez-vous banal entre amis où il n'y a pas de feu, donc des amis qui vont se rencontrer pendant deux ou trois heures et le fait d'arriver un petit peu en retard peut, pour des gens anxieux, être une véritable source de problèmes.

L'anxiété est envahissante parce que, comme je viens de le dire, ça peut être en rapport avec n'importe quel fait banal de la vie quotidienne. Elle est qualifiée de flottante parce qu'il n'y a pas de véritable chose menaçante ou dangereuse qui est à l'origine de cette anxiété. Elle est qualifiée aussi de flottante parce qu'elle est tout le temps là, prête à se fixer sur n'importe quel sujet, n'importe quel fait de la vie.

Ça commence dès le réveil, dès le matin, la personne commence à se faire des soucis pour n'importe quoi et cette anxiété va s'accroître au fil de la journée pour culminer et s'accroître le soir et être à l'origine bien sûr de problèmes de sommeil, d'endormissement et même des réveils nocturnes. La traduction se fait bien sûr sur les trois registres qu'on a vu précédemment dans l'autre rôle sur le plan psychique, physique et comportemental. Sur le plan psychique, la personne va ressentir un état de tension interne très désagréable, un malaise permanent avec un sentiment d'être surexcité, survolté et bien sûr avec un sentiment d'insécurité parce que tout peut être source de problème, tout peut être source de danger pour elle et ce climat d'insécurité va créer un état aussi d'hypervigilance et d'alerte en permanence avec une tension musculaire aussi.

Les personnes deviennent très irritables, intolérant au moindre frustration et bien sûr ça retentit aussi sur le plan cognitif avec des troubles attentionnels et mnésiques liés bien sûr à cette ambiance d'hypervigilance, d'insécurité. Sur le plan physique, cet état d'hypervigilance et d'excitation permanente et de tension permanente va se traduire aussi par une tension musculaire qui est présente tout le temps et qui va donner lieu à des douleurs parce que les muscles vont se fatiguer parce que ce sont des personnes qui sont tout le temps tendus, même pendant les périodes où ils se reposent, où ils regardent la télé, ils sont toujours en état de tension et donc ça finit par fatiguer les muscles et ça crée des douleurs, des cervicales giges, souvent des céphalées. Ce sont les principaux motifs de consultation qu'on rencontre en consultation.

Aussi une hyper réactivité du système neurovégétatif qui va se traduire bien sûr par les signes de palpitations, par des sueurs, par des bouffées de chaleur surtout et par une instabilité tensionnelle. Le sommeil, bien sûr, va être perturbé lié justement à cette anxiété et surtout c'est des insomnies d'endormissement, quand ils se retrouvent au lit, ils ont du mal à s'endormir et même quand ils retrouvent le sommeil, c'est un sommeil souvent agité avec parfois des réveils au milieu de la nuit. Sur le plan comportemental, cet état d'hypervigilance va créer un comportement de fébrilité, d'instabilité, voire carrément parfois d'une agitation importante avec des réactions de sursaut, des personnes qui sursautent au moindre stimulus, au moindre claquement de porte.

Ce sont des gens qui, du fait de cette insécurité, ont du doute par rapport au futur, par rapport aux conséquences, donc ils sont indécis, ils n'arrivent pas à prendre des décisions et ça donne lieu à une certaine procrastination avec tendance à reporter les tâches à plus tard, au lendemain

ou les semaines d'après. C'est bon ça ? Sur le plan diagnostique, les critères du DSM 5, à titre indicatif, le DSM déploie plusieurs critères pour retenir le diagnostic de troubles d'anxiété généralisé avec comme premier critère la présence de cette anxiété et ses soucis qui sont durables au-delà de six mois, donc avec la difficulté de contrôler ces préoccupations, la présence de trois signes physiques et psychiques parmi les six. Le fait que cette anxiété, ces soucis soient à l'origine aussi d'une certaine détresse, d'une certaine altération du fonctionnement du sujet aussi est un autre critère pour le diagnostic.

Et puis les autres critères, ce sont des critères d'élimination, donc cette anxiété, ces soucis ne doivent pas être liés à l'effet d'une substance ou d'une pathologie, soit organique ou psychique. Donc là, pour résumer ces critères diagnostiques, comme je viens de le dire. Après le diagnostic différentiel, pour différencier l'anxiété généralisée d'une anxiété, j'allais dire normale, comme on vient de le voir, ce sont des soucis qu'on peut tous avoir, mais ça reste des soucis qui sont contrôlables, qui sont limités dans le temps et qui sont justifiés par certaines situations et ça ne crée pas vraiment cette climat de tension ou de fébrilité.

A différencier aussi du trouble de l'adaptation, le trouble de l'adaptation, c'est un autre psychiatrique qui est lié où on peut trouver des symptômes anxieux, on peut trouver des symptômes timides de dépression ou carrément de trouble de conduite, mais qui est généralement lié à une situation stressante nouvelle que la personne subit. Des fois, ça peut être une situation transitoire, mais ça peut aussi être une situation de longue durée. Par exemple, le fait de voyager pour études dans un pays étranger peut être une situation stressante pour des gens qui n'arrivent pas à s'adapter facilement et ça peut se traduire par des symptômes anxieux qui ressemblent à l'anxiété généralisée ou par des symptômes timides qui ressemblent à la dépression, mais ce qui va les différencier, c'est surtout que quand la personne sera extraite de cette ambiance stressante, de cette situation de stress, les symptômes auront tendance à diminuer, à régresser et à disparaître.

Donc, le trouble de panique, on l'a vu la dernière fois, c'est plus des attaques de panique et pas du sévère. Le trouble obsessionnel compulsif qu'on va traiter plus tard, donc les inquiétudes et les idées obsédantes liées à ce trouble sont généralement de contenus absurdes qui ne sont pas compatibles avec ce que la personne pense et ce sont des idées qui sont intrusives malgré la personne et ça ne concerne pas uniquement les choses de la vie quotidienne, mais ça peut être des thèmes complètement bizarres, complètement absurdes. A différencier aussi d'un épisode dépressif, je ne sais pas si vous avez traité déjà la dépression ou pas encore.

Donc, comme vous avez vu dans le cours de la dépression, l'anxiété aussi fait partie des signes accompagnateurs du syndrome dépressif et dans certains cas, donc l'anxiété est tellement importante qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il se choisit d'un trouble onctueux ou la dépression, mais dans ce cas, le tableau dépressif avec l'anédonie et la tristesse va faire pencher le diagnostic plutôt vers un épisode dépressif qu'un trouble onctueux. Mais aussi, ça peut être aussi l'association des deux troubles parce que cette comorbidité, dépression et anxiété

généralisée est assez fréquente. Pour les troubles asymptomatiques, ce sont des troubles aussi où il y a des préoccupations corporelles par rapport à des défauts physiques que certaines personnes ont et ça se limite à ce genre d'inquiétude et de préoccupation.

Et puis finalement, tout ce qui est anxiété et qui peut être lié à une pathologie organique comme une hyperthyroïdie, un phéochromocytome ou lié à l'intoxication par une substance psychoactive comme une intoxication chronique d'alcool ou l'usage d'autres médicaments ou substances. Sur le plan étiopathogénique, c'est l'association de plusieurs facteurs, donc une vulnérabilité plutôt liée à la personne, associée à des facteurs environnementaux qui peuvent expliquer le développement de ces troubles. Il y a une prédisposition génétique avec des facteurs qui sont liés à la dépression.

Et sur le plan biologique aussi, il y a un certain dysfonctionnement, il y a la théorie de dysfonctionnement du neurotransmetteur, l'adrénaline et la sérotonine. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle le traitement se base aussi sur les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et ou de l'adrénaline. On invoque aussi comme hypothèse biologique un dysfonctionnement du système gabaergique, on l'a vu aussi dans le trouble panique.

Dans le trouble panique, il y a une réduction des récepteurs de benzodiazépines. Là, dans le trouble anxiété généralisée, c'est plutôt l'élévation d'un neuropeptide, le diazepam-bendine inhibiteur, qui va empêcher la liaison des benzodiazépines endogènes à leurs récepteurs. Et on sait que ce sont des récepteurs qui modulent l'action et l'activation du récepteur gabaergique, qui est un système inhibiteur du système nerveux central.

D'autres facteurs plutôt psychologiques et environnementaux, on décrit chez ces gens-là des troubles dès l'enfance, des troubles de l'attachement, des problèmes de gestion des émotions ou des contrôles de frustration. Aussi, une ambiance ou un environnement familial qui est mal équilibré avec des problèmes de relation mère-enfance, de la petite enfance. Tout ça, ça peut impacter la personnalité du sujet et le prédispose au développement de troubles ultérieurs.

Pour le modèle cognitif, donc les théories cognitives évoquent que chez ces patients, ils ont des schémas de pensées dysfonctionnelles qui vont percevoir l'environnement comme potentiellement dangereux et ils ont une certaine surestimation du risque ou de la probabilité de survenir d'événements négatifs. Mais aussi, ce sont des gens qui ont une certaine intolérance à l'incertitude. Ce sont des gens qui veulent absolument à tout prix que ce soit vraiment un risque zéro dans le futur.

Puisqu'on ne peut jamais être sûr certain de ce qui va se passer dans le futur, donc il y a toujours cette incertitude par rapport au futur. Cette incertitude va, au fur et à mesure, créer toujours ce climat de tensions, de problèmes, d'anxiété. L'évolution du trouble d'anxiété généralisée, c'est un trouble d'évolution plus chronique comparativement au trouble panique.

C'est un trouble qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, avec une évolution assez fluctuante, avec des moments où les symptômes vont s'aggraver, vont s'accroître, surtout s'il y a des événements stressants en parallèle et des moments où les choses vont plus ou moins s'atténuer. C'est un trouble aussi qui expose à beaucoup de complications, surtout des comorbidités avec d'autres troubles anxieux, avec la dépression aussi, et c'est un trouble aussi qui expose à un abus de tranquillisant de substances psychoactives, que ce soit les médicaments tranquillisants ou une substance illicite comme l'alcool ou d'autres drogues. Dans certains cas, la gêne peut être tellement importante qu'il peut aussi retentir sur le plan personnel, professionnel ou familial.

On a dit tout à l'heure que la personne va exposer son anxiété sur son entourage, sur sa famille, avec les sollicitations à chaque fois, avec le harcèlement au téléphone, par les questionnements. Il n'y a pas que la personne qui vit cette souffrance, mais même son entourage, que ce soit familial ou amical ou professionnel, peut être touché par cette anxiété. C'est bon, on avance? On arrive à la prise en charge.

Pour la prise en charge du trouble d'anxiété généralisée, ça comporte trois volets, à la part des mesures générales, des mesures psychothérapeutiques et un traitement médicamenteux. Pour les mesures générales, ça comporte d'abord l'éducation du patient. C'est intéressant de bien expliquer au patient à la fois la nature du trouble, ses symptômes, son évolution, les possibilités thérapeutiques qu'il y a, avec un langage adapté à chaque personne.

Donc, il y a une sorte d'éducation thérapeutique pour aider aussi la personne à reconnaître et comprendre ses symptômes et à comprendre son trouble. Il faut aussi conseiller plusieurs mesures hygiène diététique, notamment une alimentation équilibrée, une activité physique. Et puis, il faut aménager des moments de loisirs, de repos pour ces gens-là.

Donc, il faut que ces personnes arrivent à trouver des moments de se poser, de se relaxer avec une durée de sommeil assez suffisante. Et aussi, il faudrait toujours conseiller et essayer d'éliminer tout ce qui est substance toxique comme le tabac, l'alcool, la caféine, au moins réduire la consommation de ces substances. Ça peut aussi être des exercices de relaxation ou de yoga.

Donc, c'est très intéressant pour ces gens qui n'arrivent pas à se relâcher, donc qui sont tout le temps tombés. Donc, pour eux, les exercices de relaxation sont très intéressants, pas forcément quelque chose d'officiel. Ça peut être juste des conseils, des tutoriels, des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui peuvent les aider à mieux gérer leur stress et leur anxiété.

Donc, ces mesures générales, comme j'ai dit, sont assez intéressantes pour le trouble d'anxiété généralisé. À côté de ces mesures générales, il y a le traitement, proprement dit, l'intervention thérapeutique qui comprend la psychothérapie et la pharmacothérapie. Pour ce qui est de la psychothérapie, ça peut être une psychothérapie de soutien qui est accessible à tout le monde, que tout médecin peut proposer, qui est basé plus sur des conseils et une écoute empathique.

Donc, on essaie d'écouter les doléances, la souffrance du patient et de lui proposer des solutions et des conseils simples. Donc, ça peut aider. Les thérapies structurées et adaptées au trouble se basent surtout sur les thérapies comportementales et cognitives.

Donc, ils sont plus structurés, avec un schéma bien établi avec le thérapeute, essayant de se répéter de façon hebdomadaire. Les résultats sont assez démontrés dans les études. Donc, ces techniques vont faire appel à plusieurs méthodes.

L'approche cognitive va essayer d'aider la personne à comprendre ces mécanismes, ces processus psychiques dysfonctionnels erronés, cette surestimation des probabilités de danger, cette perception de l'environnement comme étant dangereux, cette incertitude. On va essayer de travailler, le thérapeute, bien sûr, avec le patient, va essayer de travailler à magnifier, à assouplir ce schéma dysfonctionnel pour les assouplir. Pour les techniques comportementales, ça comprend plus des exercices aussi de relaxation, mais plutôt plus thérapeutiques, qui vont aider la personne à réduire son hyperactivité neurovégétative et sa tension anxieuse et musculaire.

Le traitement médicamenteux quant à lui va faire appel à plusieurs classes thérapeutiques. D'abord, les anxiolytiques, en l'occurrence les benzodiazépines. C'est un traitement de légèreté, un traitement ponctuel, qui va améliorer l'anxiété et ça donne des résultats assez intéressants sur l'anxiété, même qui expose le risque de dépendance.

C'est un traitement de la durée, donc ne doit pas dépasser en tout cas au maximum 12 semaines, incluant la régression du trouble. Donc depuis l'instauration jusqu'à l'arrêt, ça ne doit pas dépasser 12 semaines. Comme c'est une prescription un peu plus longue par rapport au trouble panique, on préfère des molécules dont la demi-vie est plus longue et dont l'action est un peu plus prolongée, comme la bromazepam, donc l'exomil, que vous connaissez tous, l'exomil, le zepam, l'anxiol, ce sont des deux noms du même médicament.

Donc il faut bien sûr faire attention par rapport aux prescriptions, par rapport au fait que c'est des médicaments qui sont très prisés par les gens et qui sont souvent détournés de leur usage légal. Donc il faut faire attention par rapport à la prescription de ces médicaments. Et même pour les personnes elles-mêmes, parce qu'ils ressentent l'effet anxiolytique rapide de la benzodiazépine, donc ils ont tendance à les préférer aux autres médicaments.

Donc même avec les conseils, avec ce qu'on leur demande de bien respecter la durée, les personnes continuent à prendre les médicaments au-delà de la durée prescrite, donc au risque de créer des dépendances. Pour le traitement de la peur, c'est toujours les antidépresseurs. C'est la classe thérapeutique qui constitue le traitement de la peur de la plupart des troubles anxieux, d'ailleurs pour tous les troubles anxieux.

Donc en première intention, c'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc on a vu quelques molécules la dernière fois, donc qu'on a paroxétine. Les inhibiteurs de la

recapture de la sérotonine et de l'adrénaline sont aussi intéressantes.

Des fois des posologies un peu moindres que par rapport aux troubles paniques, donc comme on l'appelle la fraxine. Donc il y a deux molécules sur le marché, trois plutôt. Donc actuellement l'effexor, le vélaxor est actuellement le Vendop.

Il y a une autre molécule, la bioloxytine, donc la diolophie ou Simbalta, à la dose de 30 mg. C'est un traitement bien sûr qu'on a instauré progressivement, donc la première semaine. Dans le délai d'action, on ne peut se voir qu'après 4-6 semaines, un délai un peu plus court par rapport aux troubles paniques.

Donc c'est un traitement qui doit être maintenu au moins six mois. Donc c'est les choses rentrent dans l'ordre, c'est si on arrive à trouver une rémission importante et rapide. Donc le traitement doit durer au minimum six mois et un peu plus tard si le trouble est associé à un autre trouble anxieux ou un épisode dépressif.

Donc le traitement va être maintenu un peu plus tard. Pour l'utilité thérapeutique, la buspyrhine, c'est un anxiolytique sérotoninergique qui peut être une alternative au benzodiazépine parce qu'il n'a pas cet effet de dépendance, il n'a pas l'effet amnésien et sédatif des benzos. C'est une molécule qui, aussi dans la prescription, ne doit pas dépasser les trois mois.

Malheureusement, elle n'est pas encore commercialisée au Maroc, mais c'est une molécule intéressante qui peut faire une bonne alternative au benzodiazépine. Il y a aussi l'hydroxyzine qui est un antihistaminique, mais qui a aussi un effet anxiolytique et sédatif. Donc l'ancien Atarax, si vous le connaissez, n'est plus commercialisé seulement d'Atarax.

Actuellement, sur le marché, il y a l'Otaraxet 25. L'avantage, c'est qu'on peut prescrire de façon un peu plus dans la durée, donc il n'y a pas de risque de dépendance. Là, certains effets secondaires plutôt type atropénique, donc il faut faire attention chez les gens qui ont une hypertrophie de la prostate ou un glaucome, etc.

Voilà pour le trouble d'anxiété généralisée. Pour résumer, c'est un trouble assez fréquent. C'est une maladie qui peut être très venante, parfois même handicapante.

Le rôle du médecin généraliste, médecin de famille, est assez important dans le dépistage précoce et même dans la prise en charge de la plupart des formes de cette anxiété, et d'orienter bien sûr les formes plus graves ou qui ont d'autres complications, d'autres comorbidités, pour un avis spécialisé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au trouble d'anxiété? Oui. Ce sont surtout les particularités, c'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure dans le critère du médecin, donc le critère anxiété et soucis, c'était juste un des critères.

Il y avait d'autres, donc il faut que ce soit une anxiété incontrôlable, persistante, durable, dont le temps qui est au plus plein du tableau clinique. Tout en sachant que ce sont des troubles qui sont

très comorbides et très fréquemment associés. L'idée, c'est quand l'anxiété est importante, quand elle est très prégnante, et qu'on voit qu'il y a vraiment un tableau assez sévère, à ce moment-là, on va analyser cette anxiété.

Est-ce qu'il y a ce genre de panique répétée? On peut penser à une panique. Est-ce que c'est une anxiété liée à des soucis comme on vient de le voir? On peut penser à l'anxiété généralisée. Est-ce que c'est une anxiété liée à des idées obsédantes? On peut penser aux troubles obsessionnels compulsifs.

Est-ce que c'est une anxiété liée à certaines situations sociales qu'on va penser à des phobies? Tout simplement, c'est une anxiété qui accompagne uniquement le tableau dépressif qui vient de s'installer et sans qu'il y ait vraiment des antécédents de troubles anxieux dans le passé. Quand on a une compétence anxieuse dans le tableau dépressif, à ce moment-là, ça dépend de l'intensité de l'anxiété. Quand on voit que c'est assez gênant, par exemple, quand ça gêne les patients, ça l'empêche de dormir.

Donc, on ne peut pas non plus attendre l'action des antidépresseurs des deux, quatre, six semaines pour attendre l'effet. Donc, on peut à ce moment-là prescrire dès la première prescription en association avec le traitement antidépresseur qui est dans ce cas. C'est plutôt pour le tableau dépressif, mais on peut prescrire dès le départ à une anxiolytique qui va atténuer l'anxiété du patient, qui va l'aider à se détendre, qui va l'aider à dormir et qui va couvrir aussi cette période de délai d'action de l'antidépresseur le temps que l'humeur se stabilise petit à petit, que cette anhédonie ou cette perte de plaisir se répand.

Pour la molécule que j'ai mentionné dans ce chapitre, la bromazepam, c'est des comprimés quadricables. Donc, c'est des comprimés qu'on peut diviser en quatre. Donc, on peut donner un quart de comprimé matin et un quart de comprimé le soir, si l'anxiété n'est pas très importante.

Par contre, en fonction de l'intensité de l'anxiété, on va adapter notre prescription. Mais pour le bromazepam en général, je vous conseille d'aller toujours avec la dose la plus faible possible. Donc, juste ce qu'il faut pour apaiser et atténuer l'anxiété parce qu'ils ont aussi d'autres effets secondaires comme l'acidation, comme des problématiques, comme avec le risque de chute chez les personnes âgées.

Donc, on a dit que c'est un trouble qui se voit souvent chez les personnes âgées. Donc, il y a pas mal d'effets secondaires aussi des bromos. Donc, à prescrire avec modération.

Et surtout, le problème le plus sérieux, c'est le problème de dépendance et d'usage illicite de ces molécules. Donc, pour la bromazepam, c'est parce que les codes recyclables, c'est pour ça que j'ai une autre question. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent depuis leur domicile, s'ils ont des questions.